

Université de Constantine

2024

Faculté de médecine

3^{ème} année de m médecine

Module de sémiologie de l'appareil génital féminin

Pr K. MESGHOUNI

Les signes fonctionnels en gynécologie (2)

Objectifs

Décrire les trois types d'hémorragie génitale

Citer les causes d'une hémorragie génitale

Décrire le tableau clinique d'une rupture de la grossesse extra utérine

Plan

I .introduction

II. *Les hémorragies extériorisées*

III. *Les hémorragies non extériorisées*

IV. Les autres troubles du cycle

I introduction

Les hémorragies génitales représentent un des motifs de consultation les plus fréquents en gynécologie. Le plus souvent ces hémorragies génitales sont liées à un trouble hormonal.

- Les hémorragies extériorisées sont des pertes sanglantes suivant leur date de survenue par rapport aux règles, elles peuvent être de trois types :
 - ✓ les ménorragies,
 - ✓ les métrorragies
 - ✓ les méno-métrorragies.
- Les hémorragies non extériorisées : c'est essentiellement la rupture de grossesse extra-utérine (GEU) qui est une urgence chirurgicale

II. Les hémorragies extériorisées

A Hémorragies génitales basses

Ce sont les saignements en provenance de la partie terminale de l'appareil génital.

On distinguera

- ✓ les hémorragies vulvaires,
- ✓ les hémorragies vaginales
- ✓ et les hémorragies cervicales

B Hémorragies génitales hautes

Ce sont les saignements en provenance de la cavité utérine, extériorisés par le col. Il est habituel de classer ces saignements (d'origine utérine) en fonction de leur survenue par rapport aux règles.

B-1 Saignements contemporains des règles

1 Règles normales

La durée des règles normales se situe entre 3 et 6 jours et l'abondance entre 50 et 80 ml. Classiquement les règles sont plus abondantes les 3 premiers jours et moins abondantes ensuite. Le sang des règles normales est incoagulable.

2 Saignements anormaux pendant les règles : Ménorragies

Ce sont des anomalies du cycle menstruel par augmentation de la durée ou de l'abondance des règles.

B-2 Saignements non contemporains des règles : les métrorragies les métrorragies sont aussi des hémorragies génitales hautes mais survenant en dehors des règles.

B-2-1/ Classification des métrorragies selon la cause

Métrorragies fonctionnelles : Elles se définissent par l'absence de substratum histopathologique utérin à l'étiologie du saignement. Elles sont dues à une altération permanente ou temporaire de l'endomètre provoquée par un déséquilibre hormonal de la balance œstro-progestative.

Métrorragies organiques : Il existe une pathologie utérine, tubaire, voire ovarienne, à l'origine du saignement..

B-2-2 /Classification des métrorragies selon le terrain sur lequel elles surviennent

Par ordre chronologique, il s'agit des métrorragies de :

- la période pubertaire : qui rassemble les saignements vus chez l'enfant et les saignements contemporains de la puberté ;
- la grossesse : que l'on peut également subdiviser en métrorragies du premier trimestre de la grossesse et métrorragies de fin de grossesse ;
- la période d'activité génitale : qui surviennent donc avant la ménopause ;
- la période post-ménopausique : qui survient chez la femme ménopausée.

III. Les hémorragies non extériorisées : *la rupture de grossesse extra-utérine (GEU)* C'est une urgence chirurgicale. La grossesse extra-utérine est la nidation de l'œuf fécondé en dehors de la cavité utérine, l'ovule fécondé se fixe à la paroi de la trompe de Fallope. On parle alors de grossesse extra-utérine tubaire, elle entraîne lors de sa croissance, une déchirure de la trompe sur laquelle elle s'est insérée : c'est *la rupture de grossesse tubaire réalisant un hémopéritoine avec tableau clinique d'hémorragie interne intense* (pâleur, soif vive, pouls rapide, chute de la TA). Parfois, l'œuf s'implante dans l'ovaire, le col de l'utérus ou la cavité abdominale.

1/Facteurs de risque

Les facteurs de risque de GEU sont tous les facteurs altérant la motilité tubaire :

1. les infections génitales hautes (IGH) ; les salpingites et les endométrites
2. le tabac avec une relation effet-dose ;
3. les antécédents de chirurgie tubaire mais aussi abdomino-pelvienne à risque d'adhérences ;
4. les autres causes d'altération de la paroi tubaire : endométriose, tuberculose, bilharziose, malformation utérine ou tubaire ;

5. l'âge maternel avancée ;
6. certains types de contraception : la pilule micro-progestative, le dispositif intra-utérin (risque relatif à 3) ;
7. la fécondation in vitro : 4,5 % des FIV.

2/ Le diagnostic positif

Le diagnostic de GEU doit être évoqué chez toute femme en âge de procréer se présentant aux urgences pour des douleurs pelviennes et/ou des métrorragies.

a) L'interrogatoire

L'interrogatoire précise la date des dernières règles et doit rechercher les facteurs de risques. Les signes fonctionnels peuvent être :

- des douleurs pelviennes, latéralisées ou non du côté de la GEU,
- des métrorragies foncées et peu abondantes, classiquement « sépia » en comparaison aux métrorragies rouges et abondantes de la fausse couche,
- un retard de règles ou des dernières règles inhabituelles (inconstant),
- des signes sympathiques de grossesse (nausées, vomissements, tension mammaire),
- des douleurs scapulaires voire un malaise, agitation, angoisse dans les formes évoluées.

À noter que la GEU peut être asymptomatique.

b) L'examen clinique

-L'examen clinique débute toujours par la prise des constantes (tension artérielle, pouls, fréquence respiratoire et température), la recherche d'une pâleur cutanéomuqueuse afin de dépister au plus vite les signes de choc hémorragique.

-La palpation abdominale recherche une sensibilité latéralisée avec une éventuelle défense voire une contracture généralisée.

-Au spéculum, on précise l'origine endo-utérine des saignements.

-Le toucher vaginal retrouve un utérus moins volumineux que ne le voudrait l'âge gestationnel et provoque une douleur latéro-utérine avec parfois la palpation d'une masse. Au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur (Douglas), le toucher peut provoquer une sensibilité vive témoignant d'une irritation péritonéale en rapport avec un hémopéritoine

L'intervention d'urgence s'impose.

IV. Les autres troubles du cycle

1/**Trouble du cycle** : Pollakiménorrhée= cycle < 20j

Spanioménorrhée= cycle supérieur 45j

Anisoménorrhée= cycle irréguliers

2/ Troubles de la durée des règles

- Hypoménorrhée = règles < 3 j.
- Hyperménorrhée = règles > 8 j.
- Aménorrhée = absence totale de règles.

3/Troubles de l'abondance des règles

- Oligoménorrhée = règles trop peu abondantes.
- Polyménorrhée = règles trop abondantes.

- Ménorragies = hyperpolyménorrhée.

4/ Aménorrhée (absence totale de règles)

- Aménorrhée primaire = jamais de menstruation auparavant.
- Aménorrhée secondaire = absence de règles depuis de 3 mois

Bibliographie

1. Rose marie Hamladji. *Précis de Sémiologie, sémiologie de l'appareil génital*, pp 311-317
2. Baptiste Coustet. Sémiologie médicale, point important de l'anamnèse, PP363-4
3. Université Pierre et Marie Curie Gynécologie Niveau DCEM2 ;